外科学 颈部和胸部疾病

核心精讲·其它颈胸部疾病

（性感认识：有些外科考纲内容已总结在内科中）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

骨折特有体征：
①局部畸形
②异常活动
③骨擦音骨擦感

一、肋骨骨折

1.临床表现 123肋粗且有锁骨肩胛骨的保护,8-10肋形成肋弓,可以传导力量,不易骨折,11、12肋是浮肋不容易骨折

①第 **4-7** 肋最易骨折（死期到了）

②胸痛、呼吸浅快、断端骨擦音和骨擦感、胸廓畸形及**挤压试验阳性**、肺部感染和不张、血气胸、**肝脾损伤（腹部 B 超）**低位肋骨骨折常常合并肝脾损伤

患者不敢咳嗽,痰排不出去

刺破胸膜

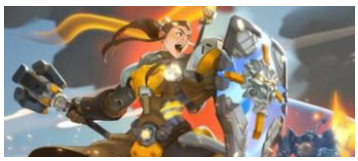
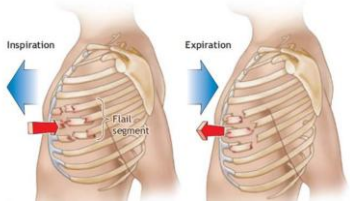
③多根多处肋骨骨折：在≥2 根**相邻**肋骨各自发生≥2 处骨折，称为**连枷胸**

《诊断学》：抑制性呼吸是因胸部剧痛致吸气突然停止（会呼吸的痛），主要见于胸部严重外伤、肋骨骨折、急性胸膜炎、胸膜恶性肿瘤




胸廓挤压试验



不存在掩盖病情

2.**控制疼痛**、早期活动、物理治疗

（1）非多根多处：**胸带**固定

（2）**多根多处** VS开放性气胸:纵隔摆动 多开摆

骨科在进行固定时,一般优先考虑外固定(不用做手术),当外固定搞不定时就考虑做手术-切开复位内固定

①胸壁软化范围小（无明显反常呼吸运动）：**胸带**固定

②胸壁**软化范围大（有明显反常呼吸运动、纵隔扑动）**：气管内插管呼吸机**正压通气**、**切开复位内固定**

失去大量肋骨支撑 两侧胸膜腔压力不平衡

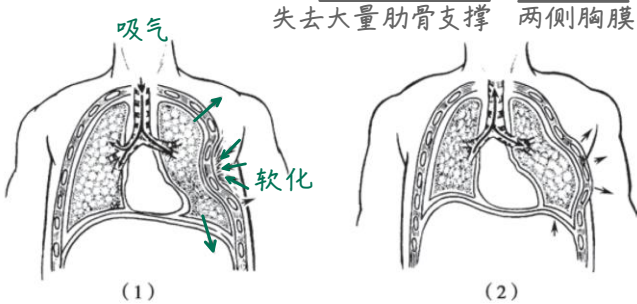


图 27-1 连枷胸,胸壁软化区的反常呼吸运动
(1)吸气 (2)呼气

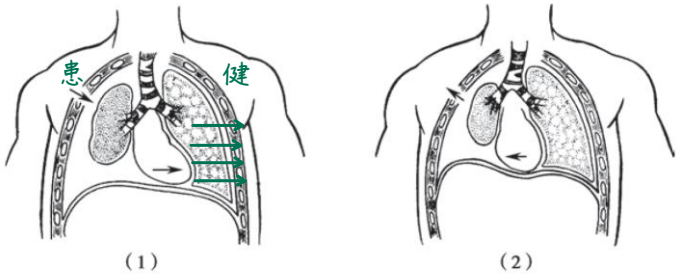


图 27-2 开放性气胸的纵隔扑动
(1)吸气 (2)呼气